

門診暴力事件應變作業流程

當門診醫護人員受到言語、肢體或暴力攻擊等威脅自身安全之行為時，請依下列應變作業流程處置：

一、即時辨識暴力前兆

- (一)於事件初期察覺暴力風險：30 秒內辨識個案是否出現提高音量、辱罵、拍桌、逼近、敵意眼神、呼吸急促、握拳等暴力前兆，並提高警覺，避免情緒進一步升高。
- (二)暴力徵兆辨識：運用「眼耳鼻舌身意」評估，觀察暴力發生前的線索。

二、保持安全距離並安撫情緒

當個案出現抱怨、音量提高（Level 1）等行為時，可先進行安撫與溝通：

- (一)確保安全：優先確保自身與周遭人員安全，避免直接正面對峙。
 - 1. 安全站位：隨時面向個案，保持兩臂距離（約 1~2 公尺），側身 45 度站位。
 - 2. 靠近出口：保留逃生動線，避免受困。
- (二)安撫情緒：以平穩、冷靜且具同理心的方式溝通，放慢語速，使用簡單明確的語句，如：「我知道您現在很不舒服」、「我們一起想辦法處理」，避免刺激性、命令式或爭辯性用詞，降低情緒升高風險。

三、啟動求助機制（叫團隊）

當個案開始指責、逼近（Level 2），或情緒持續升高、出現威脅及暴力行為（Level 3~4）時，應以「安全優先、團隊介入」為原則，立即啟動求助機制，包括：

- (一)通知支援同仁、單位主管及門診部行政人員。
- (二)啟動通報機制
 - 1. 啟動電腦暴力事件通報系統。
 - 2. 按下緊急壓扣。
 - 3. 電話通知駐警或保全人員，說明地點、人數、行為、是否持武器及是否有人員受困。
 - 4. 必要時報警處理。

四、管控場域秩序（叫周邊、叫裝備）

當個案情緒升高影響現場秩序時，由門診部行政人員、駐警隊及醫護人員共同合作維護安全。

- (一)門診部行政人員：協助疏散民眾，維持候診區動線與降低現場圍觀刺激。
- (二)駐警隊：進行現場安全警戒、危險區域控制，必要時介入保護人員安全。
- (三)醫護人員（含單位主管）：盤點團隊人員及確認約束（物理或化學）裝備。

五、避免挑釁並展現同理（CABD）

運用 CAB 風險評估及 DEFUSE 化解高張情境：

(一)CAB 低風險（個案可進行有意義對談，無立即安全危害）--進行言語降階，運用「停聽同選」技巧

- 1. 停（停下來）：停下手邊工作、面對個案、確認環境安全與出口位置。
- 2. 聽（聽他說）：讓個案說完、點頭示意、稱呼姓名、自我介紹。
- 3. 同（同理心）：同理回應、承認感受、找出個案真正需求。
- 4. 選（給選擇）：提供 2 個選項、說明可行方案、必要時升級處理。

(二)CAB 高風險（個案混亂無法進行有意義的對談，出現極為高張的情緒、過於怪異或危險的行為）--啟動升級通報

- 1. 確認後援充足，清除危險物品。
- 2. 運用「21 英尺法則」，儘量讓個案坐著，尊重其個人界線。
- 3. 支援人力抵達時，重新評估降階效果；若升溫則退避，在駐警人員協助下，進行物理或化學約束。

六、完成通報與紀錄

(一)保留相關證據，包括：監視器畫面、錄音、照片、受損物品及相關紀錄，並確認當事人資料完整；如有保全影像需求，請向駐警隊填具「監視系統影像調閱申請單」提出申請。

(二)若同仁有受傷情形，應協助就醫、驗傷及後續法律程序，必要時由駐警陪同至轄區派出所製作筆錄。

(三)駐警隊主動提供「受理醫療暴力事件通知單」審酌個案情狀填報，若決定通報，駐警隊將協助向轄區派出所、臺北地方法院檢察署及臺北市政府衛生局進行通報。

(四)通報院內異常事件備案。

七、提供現場人員正向回饋與事後關懷與支持

事件後 48 小時內應主動關懷現場同仁，必要時轉介心理支持資源（院內 3 次及院外 2 次免費心理諮商），並召開團隊檢討會議，協助同仁情緒調適與經驗回饋，提升後續應變能力。